注射用尿激酶说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【说明书修订日期】

核准日期：2022年06月29日

【药品名称】

注射用尿激酶

【注册商标】

捷隆

【英文名称】

Urokinase for Injection

【汉语拼音】

Zhusheyong Niaojimei

【成份】

本品主要成份及其化学名称为：从新鲜人尿中提取的一种能激活纤维蛋白溶酶原的酶。它是由高分子量尿激酶(Mw54000)和低分子量尿激酶(Mw33000)组成的混合物，辅料为人血白蛋白、甘露醇。

【性状】

本品为白色或类白色的冻干块状物或粉末。

【适应症】

本品主要用于血栓栓塞性疾病的溶栓治疗。包括急性广泛性肺栓塞、胸痛6～12小时内的冠状动脉栓塞和心肌梗死、症状短于3～6小时的急性期脑血管栓塞、视网膜动脉栓塞和其他外周动脉栓塞症状严重的髂-股静脉血栓形成者。也用于人工心瓣手术后预防血栓形成，保持血管插管和胸腔及心包腔引流管的通畅等。溶栓的疗效均需后继的肝素抗凝加以维持。

【规格】

10万单位

【用法用量】

本品临用前应以注射用灭菌生理盐水或5%葡萄糖溶液配制。

1.肺栓塞 初次剂量按体重4400单位/公斤，以0.9%氯化钠溶液或5%葡萄糖溶液配制，以90毫升/小时速度在10分钟内滴完；其后以每小时4400单位的给药速度，连续静脉滴注2小时或12小时。肺栓塞时，也可按每公斤体重15000单位用0.9%氯化钠溶液配制后肺动脉内注入；必要时，可根据情况调整剂量，间隔24小时重复一次，最多使用三次。

2.心肌梗死 建议以0.9%氯化钠溶液配制后，按6000单位/分速度冠状动脉内连续滴注2小时，滴注前应先行静脉给予肝素2500～10000单位。也可将本品200万～300万单位配制后静脉滴注，45分钟到90分钟滴完。

3.外周动脉血栓 以0.9%氯化钠溶液配制本品(浓度2500单位/毫升)4000单位/分速度经导管注入血凝块。每2小时夹闭导管1次；可调整滴入速度为1000单位/分，直至血块溶解。

4.防治心脏瓣膜替换术后的血栓形成 血栓形成是心脏瓣膜术后最常见的并发症之一。可用本品按体重4400单位/公斤，0.9%氯化钠溶液配制后10分钟到15分钟滴完。然后以每小时按体重4400单位/公斤的速度静脉滴注维持。当瓣膜功能正常后即停止用药；如用药24小时仍无效或发生严重出血倾向应停药。

5.脓胸或心包积脓 常用抗生素和脓液引流术治疗。引流管常因纤维蛋白形成凝块而阻塞引流管。此时可胸腔或心包腔内注入灭菌注射用水配制的本品(浓度5000单位/毫升)1万单位～25万单位。既可保持引流管通畅，又可防止胸膜或心包粘连或形成心包缩窄。
6.眼科应用 用于溶解眼内出血引起的前房血凝块。使血块崩解，有利于手术取出。常用量为5000单位用2毫升0.9%氯化钠溶液配制冲洗前房。

【不良反应】

本品临床最常见的不良发应是出血倾向。以注射或穿刺局部血肿最为常见。其次为组织内出血，发生率5%～11%，多轻微，严重者可致脑出血。本品用于冠状动脉再通溶栓时，常伴随血管再通后出现房性或室性心律失常，发生率高达70%以上。需严密进行心电监护。本品抗原性小，体外和皮内注射均未检测到诱导抗体生成。因此，过敏反应发生率极低。但有报告，曾用链激酶治疗的病人使用本品后少数人引发支气管痉挛、皮疹和发热。也可能会出现头痛、头重感，食欲不振、恶心、呕吐等胃肠症状。

【禁忌】

下列情况的病人禁用本品：急性内脏出血、急性颅内出血、陈旧性脑梗死、近两月内进行过颅内或脊髓内外科手术、颅内肿瘤、动静脉畸形或动脉瘤、血液凝固异常、严重难控制的高血压患者。相对禁忌症包括延长的心肺复苏术、严重高血压、近4周内的外伤、3周内手术或组织穿刺、妊娠、分娩后10天、活跃性溃疡病及重症肝脏疾患。

【注意事项】

1.应用本品前，应对病人进行红细胞压积、血小板记数、凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)、激活的部分凝血激活酶时间(APTT)及优球蛋白溶解时间(ELT)的测定。TT和APTT应小于2倍延长的范围内。
2.用药期间应密切观察病人反应，如脉率、体温、呼吸频率和血压、出血倾向等，至少每4小时记录1次。如发现过敏症状如：皮疹、荨麻疹等应立即停用。
3.静脉给药时，要求穿刺一次成功，以避免局部出血或血肿。
4.动脉穿刺给药时，给药毕，应在穿刺局部加压至少30分钟，并用无菌绷带和敷料加压包扎，以免出血。
5.下述情况使用本品会使所冒风险增大，应权衡利弊后慎用本品。
(1)近10天内分娩、进行过组织活检、静脉穿刺、大手术的病人及严重胃肠道出血病人。
(2)极有可能出现左心血栓的病人，如二尖瓣狭窄伴心房纤颤。
(3)亚急性细菌性心内膜炎患者。
(4)继发于肝肾疾病而有出血倾向或凝血障碍的病人。
(5)孕娠妇女、脑血管病患者和糖尿病性出血性视网膜病患者。
6.本品不得用酸性溶液稀释，以免药效下降。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

动物实验显示，本品1000倍于人用量对雌性小鼠和大鼠生殖能力及胎儿均无损伤。长期用药无致癌性报道。尚未见有严格对照组的在孕娠妇女中用药的报道。因此，除非急需用本品，否则孕妇不用。本品能否从乳汁中排泄尚无报道。因此，哺乳期妇女慎用本品。

【儿童用药】

本品在儿童中应用的安全性和有效性尚未见报道。

【老年用药】

本品在老年患者中应用的安全性和有效性尚未见确切报道。但年龄＞70岁者慎用。

【药物相互作用】

本品与其他药物的相互作用尚无报道。鉴于本品为溶栓药，因此，影响血小板功能的药物，如阿司匹林、吲哚美辛、保太松等不宜合用。肝素和口服抗凝血药不宜与大剂量本品同时使用，以免出血危险增加。

【药物过量】

本品静脉给予一般达2500单位/分方有明显疗效。成人总用药量不宜超过300万单位。溶栓药效必然伴有一定出血

风险。一旦出现出血症应立即停药，按出血情况和血液丧失情况补充新鲜全血，纤维蛋白原血浆水平＜100mg/dl伴出血倾向者应补充新鲜冷冻血浆或冷沉淀物，不宜用右旋糖酐羟乙基淀粉。氨基己酸的解救作用尚无报道，但可在紧急情况下使用。

【药理毒理】

本品直接作用于内源性纤维蛋白溶解系统，能催化裂解纤溶酶原成纤溶酶，后者不仅能降解纤维蛋白凝块，亦能降解血循环中的纤维蛋白原、凝血因子Ⅴ和凝血因子Ⅷ等，从而发挥溶栓作用。本品对新形成的血栓起效快、效果好。本品还能提高血管ADP酶活性，抑制ADP诱导的血小板聚集，预防血栓形成。本品在静脉滴注后，患者体内纤溶酶活性明显提高；停药几小时后，纤溶酶活性恢复原水平。但血浆纤维蛋白或纤维蛋白原水平的降低，以及它们的降解产物的增加可持续12～24小时。本品显示溶栓效应与药物剂量、给药的时间有明显的相关性。本品毒性很低，小鼠静脉注射半数致死量大于100万单位/公斤体重。亦无明显抗原性，致畸性，致癌性和致突变性。临床应用罕有过敏反应报道。但是，鉴于本品增加纤溶酶活性，降低血循环中的未结合型纤溶酶原和与纤维蛋白结合的纤溶酶原，可能出现严重的出血危险。

【药代动力学】

本品在人体内药代动力学特点尚未完全阐明。本品静脉给予后经肝脏快速清除，血浆半衰期≤20分钟，少量药物经胆汁和尿液排出。肝硬化等肝功能受损患者其半衰期延长。

【贮藏】

遮光，密闭，在10℃以下保存。

【包装】

管制注射剂玻璃瓶，药用氯化丁基橡胶塞。10万单位/瓶×5瓶/盒，10万单位/瓶×2瓶/盒。

【有效期】

24个月

【执行标准】

《中国药典》2020年版二部

【批准文号】

国药准字H22023692

【上市许可持有人及生产企业】

药品上市许可持有人/生产企业：吉林敖东洮南药业股份有限公司
注册地址/生产地址：吉林省洮南经济开发区兴业路2999号
邮政编码：137100
电话号码：0436-6225232 6335031